

의과대학생 정신건강 실태조사 및 학생지원 기반 마련

1차년도 성과 정리본 · 2025~2026

전국 조사와 학생 면담을 통해 조사 시점의 정신건강 상태와 지원 요구를 파악하고, 상담안내서·가이드북과 학생지원 정책 방향으로 연결했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

35개교 · 온라인 조사 참여대학

3,313명 · 최종 분석대상

23명 · 사후 FGI 참여자

- 상담안내서 개발→사전 인터뷰→전국 온라인 조사→사후 FGI→통합 분석→정신건강 상담 가이드북 개발 순으로 추진했습니다.
- 2025년 9월 15일~11월 30일 온라인 조사를 실시했습니다. 설문 참여 6,071명, 완료 3,373명 중 정제 후 3,313명을 분석했습니다.
- 사전 인터뷰는 6개교 16명, 사후 FGI는 5개 집단 23명으로 운영했습니다.
- 잠재프로파일 분석은 안정군 24.6%, 중간위험군 39.9%, 잠재위험군 11.4%, 고위험군 24.1%를 제시했습니다. 이는 분석 표본의 통계적 분류이며 임상진단이나 전국 학생의 유병률이 아닙니다.
- 본과 진입기 부담, 사회적 지지, 상담의 비밀보장·접근성, 정보 제공과 교수·동료 관계가 주요 지원 의제로 도출됐습니다.
- 상담안내서는 전국 40개교에 학교별 약 200부와 PDF로 제공했으며, 조사·면담 결과를 정신건강 상담 가이드북과 정책 제언으로 연결했습니다.

횡단적 자기보고 조사로 인과관계를 확인할 수 없습니다. 모집단 20,088명 대비 최종 분석 비율은 16.49%이며 표본의 대학·학년별 차이를 고려해야 합니다. 선별척도와 통계적 집단은 진단이 아닙니다. 개인·대학의 낙인이나 평가에 사용하지 않습니다.

주요 산출물

- 상담안내서(Short Guide)

- 전국 정신건강·학생생활 실태조사 결과
- 사전 인터뷰·사후 FGI 통합 분석
- 정신건강 상담 가이드북·정책 로드맵

세부 성과 목차

- 01 · 조사 개요와 추진 절차
- 02 · 전국 조사: 표본·정신건강 지표·집단별 분석
- 03 · 상담 가이드북 개발과 활용
- 04 · 종합 사업 결과
- 05 · 해석의 한계와 결론

01 조사 개요와 추진 절차

Ⅲ. 의과대학생 정신건강 실태조사 1. 조사 개요 가. 조사 목적 본 조사는 전국 의과대학생의 정신건강 상태와 생활 실태를 파악하고, 최근 교육 환경의 변화가 학생의 정서, 대인관계 및 공동체 경험, 학업, 진로 및 의사 정체 성, 학교 지원 경험에 미친 영향을 종합적으로 분석하기 위해 실시하였다.

또한 정신건강의 위험요인과 보호요인, 학생들이 인식하는 지원 요구를 함께 확인하여 의과대학 차원의 예방적·단계적 학생지원체계 마련을 위한 기초자료를 확보하고자 하였다.

나. 조사 대상 조사 모집단은 IRB 승인 당시 전국 40개 의과대학 재학생 19,770명으로 설정하였다.

이후 사전 조사 단계에서 「2025년 전국 의과대학 학사현황」을 기준으로 재학생 수를 20,088명으로 파악하였다.

이 가운데 온라인 설문조사 시작 전 군 입대 학생 수 2,824명을 확인하였고, 실제 설문 기간 동안의 잠재적 조사 대상 학생 수는 16,926명으로 산정하였다.

사전 인터뷰는 의과대학생의 다양한 교육 경험과 정신건강 관련 이슈를 폭넓게 탐색하기 위해 실시하였다.

2025년 5월부터 6월까지 약 6개 학교의 의예과 및 의학과 전 학년 학생을 대상으로 참여자를 모집하였으며, 총 16명을 대상으로 반구조화된 개별 인터뷰를 실시하였다.

참여자는 학년, 학번 및 소속 대학 등을 고려하여 모집하였다.

온라인 설문조사에는 전국 35개 의과대학 재학생 6,071명이 참여하였다.

설문 참여율은 설문 기간 동안의 잠재적 조사 대상 학생을 기준으로 35.87%였다.

이 중 232명을 제외한 5,840명이 연구 참여에 동의하였고, 연구 참여 동의자 가운데 3,373명이 설문을 완료하였다.

잠재적 조사 대상 학생 16,926명을 기준으로 한 설문 완료율은 19.93%였다.

온라인 설문조사는 연구 참여에 자발적으로 동의한 법적 성인 재학생을 대상으로 실시하였으며, 미성년자 및 의과대학 재학생이 아닌 경우는 조사 대상에서 제외하였다.

사후 초점집단면접(FGI)은 전국 온라인 설문조사 결과를 심층적으로 해석하고 학생들의 구체적인 경험과 지원 요구를 파악하기 위해 실시하였다.

전국 의과대학의 협조를 통해 25개 대학에서 총 137명의 지원자를 추천받았으며, 신규 입학생을 제

외한 학생을 대상으로 온라인 사전 선별 설문을 실시하였다.

사전 선별 설문에는 총 84명이 응답하였으며, 지역, 학년 및 성별과 사전 선별 결과를 종합적으로 고려하여 FGI 참여자를 선정하였다.

최종적으로 고위험군 1개 그룹, 의예과 학년별 (24·25학번) 2개 그룹, 의학과 저학년 및 고학년 각 1개 그룹 등 총 5개 그룹으로 구성하여 FGI를 실시하였다.

연구팀은 설문 완료자료의 응답 내용과 자료의 적절성을 검토하여 분석 기준에 부합하지 않는 자료를 제외하였으며, 최종적으로 3,313명을 분석대상자로 확정하였다.

다.

조사 설계와 절차 본 연구는 반구조화된 사전 인터뷰를 통해 의과대학생 정신건강과 관련된 주요 이슈를 탐색하고, 이를 바탕으로 설문 문항을 개발한 후 전국 의과대학생을 대상으로 온라인 설문조사와 사후 초점집단면접(FGI)을 단계적으로 수행하는 다단계 혼합연구(Multistage Mixed-Methods Design) 기반의 비중재적 관찰연구로 설계하였다.

정성자료는 설문 개발 단계와 조사 결과의 해석 단계에서 활용하였으며, 최종적으로 정량자료와 정성자료를 통합하여 연구 결과를 해석하였다.

또한 본 연구는 특정 질환군 간의 비교나 중재 효과의 검증을 목적으로 하지 않았으며, 이에 따라 대조군 설정이나 무작위 배정은 적용하지 않았다.

본 연구는 2025년 4월 초 기획회의를 시작으로 연구진 간 정기적인 논의를 통해 단계적으로 추진하였다.

연구진은 매주 또는 격주로 회의를 운영하며 연구의 진행 상황을 점검하고, 각 단계의 주요 사항을 논의·조정하였다.

전체 연구 절차는 다음과 같이 진행하였다.

① 사업 기획 및 사전 의견수렴 인터뷰 ② 설문 문항 및 조사도구 개발 ③ 기관생명윤리위원회(IRB) 심의 및 승인 ④ 온라인 설문 예비 운영 ⑤ 전국 온라인 설문 조사 실시 ⑥ 자료 정리 및 정량분석 ⑦ 사후 초점집단면접(FGI) 및 통합 분석 특히 정량조사를 통해 확인한 전국적 경향을 정성조사에서 도출한 학생들의 경험과 연계해 해석함으로써 연구 결과에 대한 이해를 높이고 현장 적용 가능성을 확보하고자 하였다.

02 전국 조사: 표본·정신건강 지표·집단별 분석

6. 주요 조사 결과 본 절에서는 전국 온라인 실태조사를 통해 수집된 정량자료의 기술통계 분석 결과 가운데 학생지원체계 개선과 「정신건강 상담 가이드북」의 권고안 수립에 직접 적으로 활용될 수 있는 핵심 지표를 정리했다.

의과대학생의 정신건강은 국내외 선행연구에서 일반 인구집단에 비해 상대적으로 취약한 것으로 일관되게 보고되어 왔으며, 본 조사는 한국의 의과대학 교육환경이라는 맥락에서 이러한 양상이 실제로 어떻게 나타나는지를 확인하고자 했다.

분석에 활용된 임상척도는 우울(CES-D-R), 상태불안 및 특성불안(STAI-S, STAI-T), 불면(ISI), 스트레스(PSS-10), 성인ADHD 선별(ASRS), 사회적 지지 인지 (MSPSS)이며, 의과대학 교육환경의 특성을 반영하기 위한 변수로 감정영향척도 (MEI), 관계갈등척도(RCI), 사회적 지지원(SSI), 임상적 영향척도(CEI)를 함께 포함 했다.

학년별·성별 평균 비교에는 일원배치 분산분석(ANOVA)과 독립표본t-검정을 적용했으며, 통계적 유의수준은 * $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$ 로 표기했다.

이하에서는 정량조사의 전반적 결과를 종합적으로 요약한 뒤, 주요 임상척도의 학년별·성별 분포, 성인 ADHD 및 사회적 지지, 임상적 컷오프 초과 비율, 그리고 가이드북 개발을 위한 종합 시사점의 순서로 세부 결과를 제시한다.

가. 조사 참여자의 일반적 특성 자료정제 절차를 거쳐 전국 35개 의과대학 재학생 총 3,313명을 최종 분석대상 자로 확정했다.

이는 잠재적 위험군 판별과 학년·성별 하위집단 비교가 가능한 수준의 표본을 확보한 결과이다.

참여자의 인구사회학적 구성과 주요 임상척도의 전반적 분포는 다음과 같다.

구분	범주	빈도(n)	비율(%)
성별	남	1,680	50.7
	여	1,633	49.3
학년	의예1(24학번)	495	14.9
	의예1(25학번)	790	23.8

표 10 조사 참여자의 일반적 특성(n=3,313) 성별 구성은 남 50.7%, 여 49.3%로 균형을 보였으며, 학년별로는 의예1(25학번) 응답이 23.8%로 가장 많고 고학년(의학3·4)이 각각 8.8%, 9.0%로 상대적으로 적었다.

이는 저학년의 조사 접근성이 상대적으로 높았음을 반영하며, 결과 해석 시 학년별 표본 크기의 차이를 함께 고려할 필요가 있다.

표 11 성별 x 학년별 참여자 분포

구분	범주	빈도(n)	비율(%)
	의예2	520	15.7
	의학1	506	15.3
	의학2	412	12.4
	의학3	291	8.8
	의학4	299	9.0
소속 대학	참여 대학 수	35개교	–

구분	의예1(24)	의예1(25)	의예2	의학1	의학2	의학3	의학4
남 (n)	207	424	264	267	205	154	159
여 (n)	288	366	256	239	207	137	140
합계 (n)	495	790	520	506	412	291	299

표 12 주요 임상척도의 전체 기술통계(n=3,313) 전체 표본에서 우울(CES-D-R) 평균은 11.33점으로 임상적 컷오프(≥ 16) 이하 수준이었으나 표준편차가 12.35로 개인 간 분산이 컸으며, 스트레스(PSS-10) 평균 은 17.19점으로 임상적 컷오프(≥ 14)를 상회했다.

상태·특성 불안(STAI-S/T)도 모두 컷오프(≥ 40)를 넘는 수준으로 나타나 조사 참여자의 평균적 정신건강 부담이 상당함을 시사한다.

사회적 지지 인지(MSPSS)는 7점 만점 중 5.61점으로 비교적 높은 수준이었다.

표 13 성별에 따른 주요 임상척도 평균 비교

척도	문항 수	응답 범위	평균	표준편차	산출 방식
CES-D-R (우울)	20	0-60	11.33	12.35	총점
STAI-S (상태불안)	20	20-80	43.72	7.84	총점
STAI-T (특성불안)	20	20-80	43.47	8.32	총점
ISI (불면)	7	0-28	6.68	5.61	총점
PSS-10 (스트레스)	10	0-40	17.19	5.95	총점
ASRS (성인 ADHD 선별)	18	0-4	1.19	0.80	문항 평균
MSPSS (사회적 지지)	12	1-7	5.61	1.19	문항 평균

척도	남(n=1,680)	여(n=1,633)	t	p
CES-D-R	10.77±12.76	11.91±11.89	-2.66	0.008**
STAI-S	44.50±8.13	42.91±7.45	5.89	<0.001***
STAI-T	43.37±8.45	43.57±8.18	-0.71	0.475
ISI	6.73±5.91	6.63±5.27	0.52	0.603
PSS-10	16.56±6.34	17.84±5.44	-6.22	<0.001***
ASRS(문항 평균)	1.15±0.83	1.23±0.77	-2.62	0.009**
MSPSS(문항 평균)	5.47±1.26	5.76±1.10	-7.05	<0.001***

성별 간 차이는 척도별로 방향이 일관되지 않았다.

여학생이 우울, 스트레스, ADHD 선별, 사회적 지지에서 더 높은 점수를 보인 반면, 상태불안은 남학생이 더 높게 나타났다.

특성불안과 불면에서는 유의한 성별 차이가 확인되지 않았다.

나. 정량조사 결과 종합 첫째, 의과대학생의 정신건강 상태는 단일한 특성으로 설명하기 어려운 것으로 나타났다.

잠재 프로파일 분석 결과 비교적 안정적인 집단부터 우울·불안·불면·스트레스 수준이 높고 사회적 지지가 낮은 고위험 집단까지 서로 다른 특성을 보이는 네 개의 잠재집단이 확인되었다.

최종 분석에서는 안정군 24.6%, 중간위험군 39.9%, 잠재위험군 11.4%, 고위험군 24.1%로 분류되었으며, 특히 고위험군은 우울·불면·ADHD 선별 점수가 모두 임상적 컷오프를 상회하고 사회적 지지 인지가 유의하게 낮은 특성을 보였다.

둘째, 우울, 불안, 불면 및 스트레스는 서로 밀접한 관련성을 보였으며, 사회적 지지와 긍정적인 대인관계 및 공동체 경험은 정신건강 어려움을 완화하는 보호요인으로 확인되었다.

상관분석 결과 우울(CES-D)과 불면(ISI)은 강한 정적 관계 ($r=0.64$), 우울과 MEI (감정영향척도)도 강한 정적 관계($r=0.62$)를 보였으며, MSPSS는 우울과 유의한 부적 관계($r=-0.34$)를 보였다.

셋째, 공동체 구성원과의 관계에서는 교수와의 관계 만족도가 상대적으로 낮게 나타난 반면, 가족과 친구의 지지는 비교적 높은 수준을 유지했다.

그러나 사회적 지지원 지수(SSI) 평균은 5점 척도의 중간값을 하회하는 수준(3.06)에 머물러, 위 기 상황에서 학생과 교수 간 신뢰와 소통을 강화하고 학생이 도움을 요청할 수 있는 사회적 지지체계를 확대할 필요가 있음을 시사한다.

넷째, 학생들은 의사에 대한 사회적 인식이 악화되었다고 인식하는 경향을 보였 으며, 학교의 정보 제공과 의사소통, 상담 지원에 대한 만족도 또한 전반적으로 높 지 않은 것으로 나타났다.

자살생각의 평생 유병률은 남학생 25.0%, 여학생 31.3%로 확인되었으며, 특히 여학생에서 유의하게 높았다($\chi^2=15.66$, $p<0.001$). 이 에 따라 학생지원은 개인의 정신건강 문제에 대한 지원을 넘어 정확하고 일관된 정보 제공, 학업 복귀 및 진급 지원, 관계 회복, 진로 및 의사 정체성 형성을 포괄 하는 통합적 지원체계로 운영될 필요가 있음을 확인했다.

다섯째, 복귀 이후 시간이 경과함에 따라 정신건강 상태가 모든 학생에게 동일한 양상으로 회복되는 것은 아닌 것으로 나타났다.

로지스틱 회귀분석에서 우울 고위험군($CES-D \geq 16$) 소속을 예측하는 요인 중 MEI (감정영향척도)가 가장 강력한 위험요인($OR=2.62$)이었으며 의학1 학년($OR=2.27$)이 다른 학년보다 유의하게 높은 위험을 보였다.

이에 학생지원은 학년, 복귀 시기, 기존의 취약요인 및 보호요인을 종합적으로 고려한 단계적 지원체계가 필요함을 확인했다.

본 조사 결과는 변수 간의 관련성을 분석한 결과로 인과관계를 직접 설명하는 것은 아니며, 특히 자살 및 자해 관련 결과는 학생 개인이나 특정 대학에 대한 낙인으로 해석되지 않도록 신중한 접근이 필요하다.

이상의 조사 결과는 의과대학생의 정신건강 증진과 학생지원체계 구축을 위한 기초자료로 활용되었으며, 정신건강 상담 가이드북 개발 및 향후 학생지원 정책 수립의 근거자료로 활용했다.

다.

주요 임상척도(우울·불안·불면·스트레스) 우울(CES-D), 상태·특성 불안(STAI-S, STAI-T), 불면(ISI), 스트레스(PSS-10)의 다섯 개 임상척도에 대해 학년별·성별 평균과 표준편차를 산출하고, 성별 내 학년 간 차이와 성별 간 차이를 각각 검정했다.

척도	의예1 (24)	의예1 (25)	의예2	의학1	의학2	의학3	의학4	F(p)	성별t(p)
CES-D (남)	12.5 ±13.7	6.5 ±9.4	10.9 ±12.7	13.0 ±13.4	12.7 ±13.6	12.3 ±13.9	12.1 ±13.5	11.88***	—
CES-D (여)	12.9 ±12.3	7.4 ±9.0	12.6 ±12.2	16.0 ±12.8	12.5 ±10.8	11.4 ±11.9	13.2 ±13.4	15.33***	-2.66**
STAI-S (남)	43.3 ±7.9	44.8 ±7.7	44.9 ±8.2	45.5 ±8.4	43.4 ±8.5	44.0 ±8.0	45.0 ±8.5	2.38*	—
STAI-S (여)	43.1 ±7.7	43.7 ±7.3	42.1 ±7.5	42.9 ±8.0	42.4 ±7.0	43.1 ±7.1	42.4 ±6.9	1.59	5.90***
STAI-T (남)	42.8 ±8.1	42.1 ±7.6	43.3 ±8.4	45.6 ±9.2	43.4 ±8.5	43.9 ±8.2	43.4 ±9.4	4.84***	—
STAI-T (여)	43.8 ±8.7	43.1 ±7.7	43.0 ±8.7	44.4 ±8.6	43.4 ±7.9	43.8 ±7.3	44.0 ±7.6	0.90	-0.71
ISI (남)	7.2 ±6.0	4.7 ±4.7	6.8 ±5.5	8.0 ±6.4	7.5 ±5.9	7.2 ±5.8	7.8 ±7.0	12.71***	—

표 14 CES-D, STAI-S, STAI-T, ISI, PSS-10 학년별·성별 비교 (1) 우울(CES-D)과 불면(ISI) 두 척도 모두 남녀 모두에서 학년 효과가 매우 뚜렷하게 나타났다(남: $F=11.88$, $F=12.71$, 모두 $p<0.001$; 여: $F=15.33$, $F=6.54$, 모두 $p<0.001$). 점수는 의예과 1학 년 25학번에서 가장 낮고 의학과 1학년에서 정점을 이룬 뒤 일정 수준을 유지하는 패턴이 관찰되었으며, 이는 본과 진입 시점이 임상적 부담이 가장 집중되는 구간임을 시사한다.

실제로 우울 척도의 평균은 여학생 의학과 1학년에서 16.0점으로 가장 높게 나타났고, 불면 척도 역시 남학생 의학과 1학년(8.0점)과 여학생 의학과 1학년(7.8점)에서 정점을 보여, 본과 진입 직후가 우울·불면이 동시에 악화되는 시 기임을 확인할 수 있었다.

(2) 스트레스(PSS-10) 성별 간 차이가 가장 두드러진 척도로, 여학생이 모든 학년에서 남학생보다 일관 되게 높은 점수를 보고했다($t=-6.23$, $p<0.001$). 학년 효과 또한 유의했으나(여학생 $F=4.21$, $p<0.001$; 남학생 $F=3.68$, $p<0.01$) 학년 간 변동의 폭은 크지 않았다.

이는 스트레스가 일부 시기에 국한된 문제가 아니라 의과대학 교육과정 전반에 걸친 구 조적 부담일 가능성을 시사하며, 특정 학년을 대상으로 한 개입만으로는 충분히 완화되기 어려운 특성을 지님을 보여준다.

(3) 상태·특성 불안(STAI-S/T) 상태불안(STAI-S)은 우울·스트레스와 반대로 남학생이 여학생보다 유의하게 높 게 나타났으며($t=5.90$, $p<0.001$), 특성불안(STAI-T)은 성별 간 차이가 유의하지 않았다($t=-0.71$). 남학생의 경우 학년 효과가 유의했으나(특성불안 $F=4.84$, $p<0.001$) 여학생에서는 학년 간 차이가 상대적으로 작았다.

전반적으로 의예과 1

ISI (여)	6.7 ±5.4	5.3 ±4.7	6.9 ±5.2	7.8 ±5.4	7.4 ±5.1	6.2 ±5.2	6.9 ±5.8	6.54***	0.52
PSS-10 (남)	16.6 ±6.5	15.6 ±5.5	16.7 ±6.5	17.8 ±6.8	17.1 ±6.5	16.6 ±6.6	16.1 ±6.5	3.68**	—
PSS-10 (여)	17.7 ±5.9	16.8 ±4.6	17.9 ±5.4	18.7 ±6.0	18.5 ±5.2	17.8 ±5.6	18.3 ±5.4	4.21***	-6.23***

학년 25학번이 대부분의 척도에서 가장 낮은 점수를, 의학과 1학년이 가장 높은 점수를 보이는 경향이 일관되게 확인되었다.

라. 성인ADHD 선별(ASRS) 및 사회적 지지(MSPSS) 성인ADHD 선별(ASRS)과 사회적 지지 인지(MSPSS)에 대해서도 동일하게 학년 별·성별 문항 평균과 표준편차를 산출해 비교했다.

표 15 ASRS, MSPSS 학년별·성별 비교 (1) 성인ADHD 선별(ASRS) 남녀 모두 학년에 따른 차이가 유의했으며(남학생 F=4.65, 여학생 F=3.50, 모두 $p<0.01$), 의학과 1학년에서 가장 높은 수준을 보였다.

성별 간 비교에서도 여학생 이 남학생보다 유의하게 높은 점수를 보고했다($t=-2.62$, $p=0.009$). 이는 본과 진입 직후의 학습 부담 증가와 집중력·실행기능 자원의 부족이 ADHD 선별 양성률 상 승과 관련될 가능성을 시사한다.

(2) 사회적 지지 인지(MSPSS) 여학생은 학년 간 차이가 유의하지 않았으나($F=1.64$, $p=0.131$), 남학생은 학년이 올라갈수록 사회적 지지 인식이 점진적으로 감소하는 경향을 보였다($F=4.55$, $p<0.001$). 성별 간 차이 또한 매우 크게 나타났으며($t=-7.07$, $p<0.001$), 여학생이 모든 학년에서 더 높은 사회적 지지 인지를 보고했다.

척도	의예1 (24)	의예1 (25)	의예2	의학1	의학2	의학3	의학4	F(p)	성별t(p)
ASRS (남)	1.2 ±0.9	1.0 ±0.8	1.1 ±0.8	1.3 ±0.9	1.2 ±0.8	1.3 ±0.8	1.1 ±0.9	4.65***	—
ASRS (여)	1.3 ±0.8	1.1 ±0.7	1.2 ±0.7	1.3 ±0.7	1.3 ±0.8	1.1 ±0.8	1.2 ±0.9	3.50**	-2.62**
MSPSS (남)	5.5 ±1.3	5.7 ±1.1	5.5 ±1.2	5.4 ±1.2	5.2 ±1.3	5.3 ±1.5	5.3 ±1.3	4.55***	—
MSPSS (여)	5.7 ±1.1	5.8 ±1.1	5.8 ±1.1	5.8 ±1.1	5.7 ±1.0	5.7 ±1.1	5.6 ±1.1	1.64	-7.07***

마. 임상적 컷오프 초과 비율 각 척도에 표준 컷오프(CES-D ≥ 16 , STAI-S/T ≥ 40 , ISI ≥ 8 , PSS-10 ≥ 14 , ASRS 첫 6문항 중 4문항 이상 양성)를 적용해 임상적으로 유의한 수준에 해당하는 학생의 비율을 산출했다.

이는 평균 점수의 차이를 넘어 실제 위험군의 규모를 가늠하게 한다는 점에서, 자원 배분의 우선순위를 결정하는 데 직접적인 시사점을 제공한다.

표 16 성별x학년별 임상척도 컷오프 초과 비율

척도	성별	의예1 (24)	의예1 (25)	의예2	의학1	의학2	의학3	의학4
CES-D (≥ 16)	남	34.8%	13.7%	28.0%	37.5%	32.7%	29.9%	30.8%
CES-D (≥ 16)	여	31.6%	14.5%	30.1%	44.4%	34.3%	27.0%	33.6%
STAI-S (≥ 40)	남	67.1%	76.7%	79.9%	80.1%	66.8%	76.6%	74.8%
STAI-S (≥ 40)	여	66.7%	69.7%	62.1%	65.3%	64.7%	70.8%	65.0%
STAI-T (≥ 40)	남	64.3%	63.7%	67.0%	73.4%	63.4%	68.8%	64.2%
STAI-T (≥ 40)	여	63.9%	67.5%	66.0%	66.5%	65.2%	69.3%	72.1%
ISI (≥ 8)	남	38.6%	23.8%	38.3%	47.6%	40.5%	43.5%	41.5%
ISI (≥ 8)	여	37.5%	24.3%	35.9%	47.7%	41.5%	32.1%	37.9%
PSS-10 (≥ 14)	남	75.4%	73.1%	76.1%	78.3%	77.1%	76.0%	75.5%
PSS-10 (≥ 14)	여	83.3%	82.2%	84.4%	84.9%	88.4%	83.2%	86.4%
ASRS (4+)	남	37.2%	33.0%	36.7%	41.9%	34.6%	40.3%	33.3%
ASRS (4+)	여	43.4%	33.9%	30.5%	43.5%	36.2%	32.1%	32.1%

(1) 스트레스(PSS-10)의 만성·구조적 부담 가장 높은 비율의 학생이 컷오프를 초과한 척도로, 여학생은 모든 학년에서 80% 이상이 임상적 스트레스 수준에 해당했다.

학년에 무관하게 매우 안정적으로 높은 수준이 유지된 점은 스트레스가 의과대학 교육과정 전반에 걸친 환경적·구조적 요인에 의해 유발되고 있을 가능성을 강하게 시사한다.

(2) 우울(CES-D)과 불면(ISI)의 의학과1학년 정점 두 척도 모두 의학과 1학년에서 가장 큰 정점을 보였으며, 특히 여학생 의학과 1학년에서는 44.4%가 우울 위험군, 47.7%가 불면 위험군에 해당해 본과 진입 직 후 시기가 가장 취약한 구간임이 분명하게 드러났다.

(3) 불안(STAI)의 일관된 고수준 상태불안과 특성불안 모두 모든 학년에서 60~80% 수준의 컷오프 초과 비율이 일관되게 관찰되었다.

상태불안은 남학생에서 더 높게 나타났으며, 특성불안은 학년이 올라감에 따라 성별 간 차이가 좁혀지는 양상을 보였다.

바. 자살·자해 관련 경험 본 절의 결과는 조사 시점에 수집된 응답을 바탕으로 산출한 유병률로, 특정 대 학이나 개인에 대한 낙인이나 평가로 해석해서는 안 된다.

또한 유병률의 절대적 인 수준은 조사도구, 설문 시기 및 응답 환경 등에 따라 영향을 받을 수 있으므로, 결과는 학년·성별·시점에 따른 상대적 차이를 중심으로 해석하는 것이 적절하다.

자살 관련 경험은 자살생각, 자살계획, 자살시도, 비자살성 자해의 네 개 지표에 대해 최근 1개월, 최근 1년, 평생의 세 시점으로 각각 예/아니오 방식으로 조사했다.

학년·성별별 유병률을 산출하고 성별 차이는 χ^2 검정, 학년 간 차이는 학년(7 수준) × 응답 이원 교차표에 대한 χ^2 검정으로 확인했다.

이는 2018·2023년 자살 실태조사에서 채택한 자살 역학조사 표준방식과 일치한다.

표 17 자살생각(Suicidal Ideation) 유병률 (시점x성별x학년) 표 18 자살계획·자살시도·자해 유병률 요약

시점	성별	전체	의예1 (24)	의예1 (25)	의예2	의학1	의학2	의학3	의학4	성별차 $\chi^2(p)$	학년차 $\chi^2(p)$
1개월	남	7.4% (124/1676)	5.3%	3.8%	9.9%	10.1%	8.8%	10.4%	6.3%	0.03 (0.87)	42.54 (<0.001)
1개월	여	7.2% (117/1627)	4.5%	3.3%	10.6%	12.2%	8.3%	8.8%	5.0%		
1년	남	11.9% (200/1676)	12.6%	7.6%	14.8%	11.7%	14.2%	14.9%	12.6%	0.41 (0.52)	28.29 (<0.001)
1년	여	12.7% (207/1626)	15.3%	6.3%	15.0%	14.7%	12.6%	12.5%	17.1%		
평생	남	25.0% (419/1675)	27.3%	20.6%	25.4%	24.0%	28.9%	30.5%	24.5%	15.66 (<0.001)	24.42 (<0.001)
평생	여	31.3% (509/1628)	31.6%	24.7%	28.2%	33.2%	38.3%	37.5%	33.6%		

지표	성별	1개월	1년	평생	성별차 $\chi^2(p)$	학년차 $\chi^2(p)$
자살계획	남	1.7% (28/1672)	3.5% (59/1671)	7.5% (125/1673)	5.27 (0.022)*	10.95 (0.089)
자살계획	여	0.7% (12/1625)	1.8% (30/1625)	8.2% (134/1625)	—	—
자살시도	남	0.5% (9/1676)	1.4% (23/1673)	3.6% (60/1675)	1.94 (0.16)	7.18 (0.31)
자살시도	여	0.2% (3/1624)	0.4% (7/1625)	2.5% (41/1625)	—	—
비자살성 자해	남	1.6% (27/1676)	3.8% (63/1671)	8.2% (136/1657)	3.97 (0.046)*	2.62 (0.86)
비자살성 자해	여	1.1% (18/1626)	3.3% (54/1622)	10.3% (166/1614)	—	—

(1) 자살생각의 학년별 정점과 여성 우위 자살생각은 시점에 무관하게 학년 간 차이가 매우 유의했다(모든 시점 $p<0.001$). 최근 1개월과 1년 시점에서는 의예과 1학년(25학번)이 가장 낮고 본과 진입 이후 급증하는 패턴이 관찰되었다.

평생 유병률은 여학생이 남학생보다 유의하게 높았 으며(31.3% vs 25.0%, $\chi^2=15.66$, $p<0.001$), 여학생 의학과 2·3학년에서 각각 38.3%, 37.5%로 가장 높은 수치를 보였다.

이는 우울·스트레스 지표에서 여학생이 높은 부담을 보인 결과와 일관된다.

(2) 자살계획·자살시도의 남성 우위 자살계획과 자살시도의 최근 1개월·1년 시점에서는 남학생이 여학생보다 유의하게 높았다(1개월 자살계획 남 1.7% vs 여 0.7%, $p=0.022$; 1년 자살시도 남 1.4% vs 여 0.4%, $p=0.008$). 자살생각은 여성에서 높지만 실제 행동화된 계획·시도는 남성에서 더 빈번하다는 이 패턴은 국내 청소년·청년 자살행동 연구에서 반복적으로 확인되는 성별 역설과 일치한다.

다만 평생 시점에서는 자살계획의 성별 차이가 완화되었으며(남 7.5% vs 여 8.2%), 이는 시점별 위험 프로파일이 달라짐을 시사한다.

(3) 비자살성 자해의 여성 우위 비자살성 자해의 평생 유병률은 여학생 10.3%, 남학생 8.2%로 여학생에서 유의하게 높았다($\chi^2=3.97$, $p=0.046$). 자해는 자살생각·시도와 구분되는 감정조절 실패 및 자기처벌 동기와 관련된 것으로 알려져 있으며, 본 조사 결과는 여학생에서 감정조절 관련 개입 자원의 확대가 필요함을 시사한다.

(4) 종합: 자살행동의 성별·시점별 이중 구조 종합하면, 자살행동은 여성에서 사고(자살생각)와 자해가 더 흔한 반면 남성에서 계획·시도의 최근 발생이 더 흔한 이중 구조를 보였다.

이는 성별에 관계없이 위험 군을 조기 발견하되, 남학생에 대해서는 자살계획·시도의 최근 발생을 표적으로 하는 위기개입(수단제한, 응급대응 등)을, 여학생에 대해서는 자살생각·자해의 만성적 관리와 감정조절 지원을 우선하는 성별 맞춤형 접근이 필요함을 시사한다.

사. 의정사태 관련 지수(MEI/RCI/SSI/CEI)의 신뢰도와 학년·성별 분포 의정사태 상황에서 학생의 정서적·관계적·공동체적 경험을 다차원으로 측정하기 위해 감정영향척도(MEI, 7문항), 관계갈등척도(RCI, 4문항), 사회적 지지원 지수 (SSI, 6문항), 공동체 경험 지수(CEI, 11문항)를 자체 개발해 사용했다.

모든 척도는 5점 Likert 방식(1~5)으로 응답하며 문항 평균값으로 산출했다.

각 척도의 신뢰 도는 Cronbach's α 를 이용하여 평가하였고, 요인구조의 타당성은 KMO 표본적합 도와 Bartlett의 구형성 검정을 통해 확인했다.

학년별 평균 차이는 성별 내 일원 배치 ANOVA로, 성별 간 차이는 독립표본 t-검정으로 검증했다.

표 19 MEI, RCI, SSI, CEI의 신뢰도 및 타당도 요약 신뢰도·타당도 분석 결과 MEI와 CEI는 α 계수와 KMO 값 모두에서 우수한 심리 측정 특성을 보였으며, SSI 또한 다요인 구조를 반영해 양호한 수준으로 확인되었다.

RCI는 $\alpha=0.680$ 으로 임계값 0.70에 근접하나 이에 미치지 못하는 제한적 신뢰 도를 보였으며, 이는 문항 수가 4개로 적은 점과 관계 대상(동기·선배·후배·교수)의 이질성이 반영된 결과로 해석된다.

이하 학년·성별 비교에서도 RCI 결과는 이러한 심리측정적 한계를 고려해 해석할 필요가 있다.

척도	문항 수	Cronbach's α	KMO	Bartlett χ^2 (p)	요인 수	요약 평가
MEI (감정영향)	7	0.916	0.914	15865.7 (<0.001)	3	신뢰도·타당도 모두 우수
RCI (관계갈등)	4	0.680	0.670	2485.8 (<0.001)	2	제한적 타당도
SSI (사회적 지지)	6	0.792	0.768	7305.0 (<0.001)	3	다요인 구조, 타당도 양호
CEI (공동체 경험)	11	0.814	0.885	14995.9 (<0.001)	3	이론적 구조 일치, 타당도 높음

표 20 MEI, RCI, SSI, CEI 학년별·성별 비교 (1) 감정영향(MEI): 여성 우위와 25학번 저점 MEI는 여학생이 남학생보다 유의하게 높았으며($t=-6.39$, $p<0.001$), 학년 효과 또한 매우 뚜렷했다(남 $F=30.19$, 여 $F=22.62$, 모두 $p<0.001$). 의예과 1학년 25학 번에서 남녀 모두 최저값(2.06, 2.40)을 보인 반면 상급 학년으로 갈수록 증가하는 패턴이 관찰되었다.

이는 25학번이 의정사태 이후 입학한 코호트로서 사태의 정서 적 영향에 직접 노출된 정도가 상대적으로 낮은 특성을 반영한다.

(2) 관계갈등(RCI): 25학번 정점 후 감소하는 U자형 RCI는 다른 척도들과 상이한 학년별 패턴을 보였다.

25학번에서 가장 높은 값 (남 2.99, 여 2.92)을 보인 뒤 학년이 올라갈수록 점진적으로 감소해 의학과 4학년 에서 최저(남 2.61, 여 2.52)에 도달했다(모든 성별 $p<0.001$). RCI는 5점 척도에서

척도	의예1 (24)	의예1 (25)	의예2	의학1	의학2	의학3	의학4	F(p)	성별 t(p)
MEI (남)	2.90 ±1.17	2.06 ±0.94	2.69 ±1.04	2.81 ±1.05	2.88 ±1.10	2.86 ±1.13	2.95 ±1.05	30.19* **	—
MEI (여)	3.16 ±1.01	2.40 ±0.94	2.88 ±1.00	2.91 ±1.01	3.03 ±0.91	2.84 ±1.05	3.25 ±0.95	22.62* **	-6.39** *
RCI (남)	2.61 ±0.62	2.99 ±0.43	2.83 ±0.51	2.87 ±0.55	2.72 ±0.51	2.66 ±0.60	2.61 ±0.58	20.12* **	—
RCI (여)	2.47 ±0.61	2.92±0 .35	2.80±0 .52	2.81±0 .47	2.70±0 .55	2.70±0 .50	2.52±0 .56	27.03* **	3.94***
SSI (남)	2.89 ±0.76	3.35±0 .71	3.18±0 .73	3.10±0 .65	3.05±0 .67	3.04±0 .80	2.85±0 .69	15.54* **	—
SSI (여)	2.90 ±0.66	3.35±0 .67	3.24±0 .68	3.09±0 .64	2.90±0 .63	3.11±0 .65	2.72±0 .67	25.96* **	1.20 (0.229)
CEI (남)	2.75 ±0.64	3.02±0 .46	2.98±0 .52	2.94±0 .45	2.87±0 .59	2.83±0 .58	2.76±0 .60	9.91***	—
CEI (여)	2.67 ±0.58	2.93±0 .44	2.93±0 .52	2.91±0 .46	2.86±0 .50	2.79±0 .53	2.71±0 .56	11.12* **	3.56***

3점이 '변화 없음'을 의미하므로 25학번의 3점 근접값은 관계 변화가 상대적으로 크지 않음을, 상급 학년의 낮은 값은 관계가 악화되었음을 시사한다.

다만 RCI의 신뢰도($\alpha=0.680$)가 제한적이므로 절대값보다 학년별 상대적 패턴에 초점을 두어 해석할 필요가 있다.

(3) 사회적 지지원(SSI): 25학번 정점 후 지속 감소 SSI는 학년 효과가 매우 유의했으나(남 $F=15.54$, 여 $F=25.96$, 모두 $p<0.001$) 성 별 간 차이는 유의하지 않았다 ($t=1.20$, $p=0.229$). 남녀 모두 25학번에서 최고 (3.35, 3.35)를 보이고 이후 지속적으로 감소해 의학과 4학년에 최저(남 2.85, 여 2.72)에 이르는 패턴이 관찰되었다.

학년이 올라갈수록 학생이 지각하는 사회적 지지 자원이 체계적으로 약화된다는 이 결과는 고학년을 대상으로 한 지지체계 강화가 필요함을 시사한다.

(4) 공동체 경험(CEI): 완만한 감소와 여성 우위 CEI는 학년 효과가 유의하고(모든 성별 $p<0.001$) 성별 차이도 확인되었다 ($t=3.56$, $p<0.001$, 남>여). 25학번에서 정점을 보이고 이후 완만하게 감소하는 패턴은 SSI와 유사하나 감소폭은 상대적으로 작았다.

CEI가 공동체 활동 경험의 질 을 측정한다는 점을 고려하면 상급 학년으로 갈수록 임상실습 등 개별화된 학습 활동이 늘어나며 공동체적 경험이 상대적으로 위축될 가능성을 시사한다.

아. 종합 시사점 본 정량분석은 「정신건강 상담 가이드북」의 권고안 수립과 관련해 다음 다섯 가지 핵심 시사점을 제공한다.

첫째, 의학과 1학년(본과 진입 직후) 시기가 우울·불만을 포함한 다수의 임상적 도에서 가장 취약한 구간으로 확인되었다.

잠재 프로파일 분석에서도 고위험군의 23.0%가 의학1에 집중되었으며, 로지스틱 회귀에서 의학1은 다른 요인을 통제한 후에도 우울 고위험 확률이 2.27배 높았다.

이 시기를 중심으로 한 선별 및 조기 개입 자원의 우선 배치가 권고되며, 신입생을 대상으로 한 상담 첫 방문(opt-out) 모델이 본과 1학년 진입기에도 확대 적용될 필요가 있다.

둘째, 스트레스 컷오프 초과 비율은 학년·성별과 거의 무관하게 매우 높은 수준을 유지했다.

이는 스트레스가 일부시기에 국한된 개인적 문제가 아니라 의과대학

교육과정 전반의 구조적 부담임을 시사하며, 개인의 회복력 강화만이 아니라 학업 환경, 평가 체계, 지원 인프라를 포함한 시스템적 접근이 필요함을 뒷받침한다.

셋째, 자살·자해 관련 경험은 성별·시점별 이중 구조를 보였다.

여학생에서 자살 생각과 자해가 더 흔한 반면, 남학생에서는 자살계획·시도의 최근 발생이 더 흔했다.

이에 따라 성별 맞춤형 위기개입 전략이 필요하며, 남학생에 대해서는 수단제 한과 응급대응을, 여학생에 대해서는 감정조절과 자해 관리를 각각 강조하는 이원화된 접근이 요구된다.

넷째, 잠재 프로파일 분석에서 확인된 4개 하위집단(안정군 24.6%, 중간위험군 39.9%, 잠재위험군 11.4%, 고위험군 24.1%)은 서로 다른 임상적·인구사회학적 특성을 가진 이질적 집단이다.

따라서 일률적 지원이 아닌 4단계 층화적 지원 전략 —즉 안정군에는 유지·예방 프로그램, 중간위험군에는 정기 선별과 저강도 개입, 잠재위험군에는 불안 특이 대응, 고위험군에는 즉각적 임상 개입—이 근거 기반으로 권고된다.

다섯째, 통합 회귀분석 결과 MEI(의정사태 감정영향)가 가장 강력한 우울 위험요 인이며 MSPSS(사회적 지지 인지)가 유일한 강력 보호요인이었다.

성별·학년의 겹으로 드러난 차이는 상당 부분 이러한 심리사회적 경로를 통해 매개될 가능성이 크다.

따라서 가이드북은 (a) 의정사태 관련 정서적 여파를 감쇄하는 정보제공·대응 프로토콜, (b) 본과 진입 시기 학생에 대한 집중 지원, (c) 사회적 지지망 강화(동료 지원·멘토링 프로그램)를 세 축으로 하는 학생지원체계를 권고할 필요가 있다.

남 학생에서 학년이 올라갈수록 사회적 지지 인지가 감소하는 경향은 특히 고학년 남 학생을 대상으로 한 연결성 강화 및 동료 지지(Peer Support) 프로그램의 중요성 을 뒷받침한다.

이상의 조사 결과는 의과대학생의 정신건강 증진과 학생지원체계 구축을 위한 기초자료로 활용되었으며, 정신건강 상담 가이드북 개발 및 향후 학생지원 정책 수립의 근거자료로 활용했다.

03 상담 가이드북 개발과 활용

IV. 정신건강 상담 가이드북 개발 1. 개발 목적 「정신건강 상담 가이드북」은 전국 의과대학생 정신건강 실태조사와 사전 의견수렴 인터뷰, 사후 초점집단면접(FGI)을 통해 확인된 학생들의 어려움과 지원 요구를 바탕으로 의과대학이 학생 정신건강을 체계적으로 지원하기 위해 공유해야 할 기본 원칙과 구체적인 실천 방향을 제시하고자 개발하였다.

가이드북은 학생 정신건강을 개인의 취약성이나 상담센터만의 업무로 한정하지 않고 교육의 질과 학생 웰빙, 교수-학생 관계, 평가와 학사제도, 도움 요청 문화 및 대학의 지원체계가 함께 다루어야 할 의학교육의 과제로 제시하였다.

이를 바탕으로 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC) 차원의 공통된 학생 정신건강 지원 원칙을 마련하고, 각 대학이 규모·재정·조직·학사 운영방식에 따라 학생지원체계를 수립하거나 보완할 때 참고할 수 있는 정책·실무자료를 제공하고자 하였다.

교수자에게는 전문상담가나 치료자의 역할을 부여하기보다, 학생의 변화와 위험 신호를 조기에 알아차리고 공감적으로 대화한 후 적절한 교내 지원체계 또는 정신건강 전문기관으로 연결할 수 있도록 실천적 지침을 제공하고자 하였다.

학생에게는 자신의 정신건강 상태와 위험 신호를 점검하고 자기돌봄을 실천하며, 필요한 시점에 주저하지 않고 도움을 요청할 수 있도록 관련 정보를 제공하였다.

또한 어려움을 겪는 동료를 적절한 지원 자원으로 연결할 수 있도록 필요한 정보를 함께 제공하고자 하였다.

가이드북의 직접적인 독자는 ① 의과대학 운영·행정 담당자 및 학장단, ② 학생 면담과 지도를 담당하는 교수진, ③ 의과대학생으로 설정하였다.

이를 통해 개인 수준의 자기돌봄과 초기 면담에서부터 대학 차원의 제도적 안전망과 위기대응체계에 이르기까지 예방적·단계적 학생지원체계를 구축하는 데 기여하고자 하였다.

2. 개발 과정 정신건강 상담 가이드북 개발은 2025년 9월부터 추진하였다.

사업 초기 개발한 「상담안내서(Short Guide)」를 기반으로 전국 의과대학생 정신건강 실태조사와 사전 인터뷰, 사후 초점집단면접(FGI) 결과를 반영하여 내용을 보완·고도화하였다.

먼저 국내 대학의 학생지원 및 상담 관련 자료를 검토하고, 해외 의과대학 및 의학교육 관련 기관에서 제시한 학생 정신건강 및 웰빙 관련 가이드라인과 지원체계를 분석하여 의과대학 교육환경에 적합한 개발 방향을 수립하였다.

주요 검토

내용은 위기 대응체계 구축, 동료지원 및 멘토링, 번아웃과 스트레스 관리, 도움 요청 문화 조성, 교육환경 개선, 취약집단 지원 및 위기 상황별 대응체계 등이었다.

초기에는 학생의 위험도와 문제 유형에 따른 상담 매트릭스 형태의 구성을 검토하였다.

그러나 교수자의 역할이 학생의 진단이나 치료로 확대되지 않도록 개발 방향을 재정립하였으며, 이에 따라 가이드북은 학생지원의 기본 원칙, 교수자의 초기 상담 역할, 학생의 자기점검 및 도움 요청, 대학의 학생지원체계를 중심으로 구성하였다.

가이드북의 주요 내용은 전국 온라인 실태조사에서 확인된 학생들의 정신건강과 교육 경험을 주요 근거로 반영하였다.

특히 사회적 지지, 학생-교수 관계, 학교의 정보 제공 및 학생지원, 학업과 진로 부담 등에 관한 조사 결과를 반영하였으며, 사전 인터뷰와 사후 초점집단면접(FGI)에서 확인된 학생들의 실제 경험과 지원 요구를 사례와 행동지침에 반영하였다.

전국 온라인 실태조사에서 학생들의 정신건강 위험 수준이 다양하게 나타난 점을 반영하여 가이드북에는 전체 학생을 위한 예방적 지원부터 위험 신호의 조기 발견과 초기 면담, 교내 지원 및 전문기관 연계로 이어지는 단계적 학생지원체계를 제시하였다.

또한 사회적 지지와 긍정적인 관계 경험이 보호요인으로 확인된 결과를 바탕으로 교수자의 공감적 면담, 동료지원 및 공동체·관계 회복에 관한 지침을 구체화하였다.

학교의 정보 제공과 상담지원에 대한 만족도가 높지 않았던 점을 고려하여 신뢰할 수 있는 정보 제공, 학생 참여형 의사소통, 상담의 자발성·접근성·익명성 보장, 상담과 평가의 분리 및 외부 전문기관 연계 등을 대학 차원의 학생지원 원칙과 권고사항에 반영하였다.

또한 사후 FGI에서 도출된 불확실성, 신뢰 저하, 공동체 경험 및 전문직 정체성의 변화는 학생 정신건강을 개인의 증상이나 취약성에만 국한하지 않고 교육환경, 학사운영, 교수-학생 관계 및 대학의 지원체계와 연계하여 접근하는 근거로 활용하였다.

교수와의 상호작용 및 실제 상담 경험을 토대로 교수용 가이드에는 학생의 변화를 알아차리는 방법, 공감적 초기 면담 및 위기 상황별 연계 절차를 제시하였다.

학생용 가이드에는 불안, 무기력, 번아웃, 진로 혼란과 도움 요청의 어려움에 대응할 수 있도록 자기점검, 자기돌봄, 동료지원 및 전문기관 이용 방법을 구체적으로 수록하였다.

표 24 연구 결과를 반영한 가이드북 구성 방향 2026년 6월 말에는 정신건강의학과 및 의학교육 분야 전문가의 검토를 거쳐 최종 원고를 마련하였으며, 전공의 및 학생을 대상으로 사용자 의견을 수렴하여 내용의 타당성과 현장 적용성을 보완하였다.

이후 7월 말까지 최종 원고에 대한 검토를 진행하고, 편집 및 디자인 작업과 KAMC 이사회 및 학장단의 승인 절차를 거쳐 8월에 최종본을 발간·배포하였다.

3. 정신건강 상담 가이드북 구성 정신건강 상담 가이드북은 전국 의과대학생 정신건강 실태조사와 사후 초점집단 면접(FGI) 결과를 바탕으로, 의과대학에서 활용할 수 있는 학생 정신건강 지원의 기본 원칙과 실천 방향을 제시하는 형태로 구성하였다.

학생 정신건강을 개인의 문제에 국한하지 않고 교육환경과 학생지원체계가 함께 다루어야 할 과제로 인식 하였으며, 학생의 웰빙 증진과 예방 중심의 학생지원 체계 구축을 기본 방향으로 설정하였다.

가이드북은 학생 정신건강 지원을 위한 다음의 다섯 가지 원칙을 중심으로 구성 하였다.

첫째, 학생 웰빙과 교육의 질을 연계하는 관점이다.

학생의 웰빙은 교육의 질과

연구 결과	가이드북 반영 방향	주요 수록 내용
정신건강 위험 수준의 다양성 확인	단계적 학생지원체계 구축	예방-조기발견-초기상담-교 내지원-전문기관 연계
사회적 지지의 보호효과 확인	관계 중심 지원 강화	공감적 면담, 동료지원, 공동체 회복
상담지원 만족도 부족	접근성 및 신뢰성 향상	정보 제공, 익명성 보장, 상담과 평가 분리, 전문기관 연계
교육환경의 영향 확인(FGI)	시스템 관점의 학생지원	교육환경·학사운영·교수학생 관계 개선 방향
교수 상담 경험 분석	교수 상담역량 강화	학생 변화 인지, 초기면담, 위기대응 절차
학생들의 도움요청 어려움 확인	자기관리 역량 지원	자기점검, 자기돌봄, 동료지원, 기관 이용 안내

밀접하게 관련되며, 정신건강은 개인이나 상담기관만의 책임이 아니라 교육환경과 대학의 지원체계가 함께 다루어야 할 과제로 제시하였다.

둘째, 도움 요청을 전문성과 자기관리의 일부로 인식하는 것이다.

정신건강의 어려움을 경험할 때 도움을 요청하는 행동을 학생의 전문성과 자기관리 역량의 일부 로 인식하도록 하여, 도움 요청에 대한 부담과 낙인을 낮추고 적절한 지원을 받을 수 있는 문화를 조성하고자 하였다.

셋째, 개인과 교육환경을 함께 고려하는 구조적 접근이다.

개인의 회복력 향상뿐 만 아니라 학업환경, 평가체계, 학생지원 인프라 및 조직문화 등 학생의 정신건강 에 영향을 미치는 교육환경 전반의 개선을 함께 강조하였다.

넷째, 안전하고 접근 가능한 학생지원체계를 구축하는 것이다.

비밀보장, 접근성 높은 상담체계, 상담 및 치료 이용에 따른 불이익 방지, 전문기관 연계체계 구축 등을 학생지원의 기본 원칙으로 제시하였다.

다섯째, 학생이 참여하는 공동설계(Co-creation)를 지향하는 것이다.

학생지원 프로그램의 기획·개발·운영 과정에 학생이 함께 참여하도록 하여 학생의 실제 경험 과 요구가 학생지원체계에 반영될 수 있도록 하는 원칙을 제시하였다.

본 가이드북은 대학 인증이나 기관 평가를 위한 규정이나 평가기준이 아니라, 각 대학이 학생지원체계를 구축하고 운영하는 과정에서 참고할 수 있는 정책자료 이자 실무 지침으로 개발하였다.

또한 상담 및 위기 대응에 관한 내용은 교육적·행정적 지원을 위한 안내를 목적으로 하며, 정신건강의학과 전문의의 진단과 치료를 대체 하지 않음을 명확히 하였다.

주요 구성은 다음과 같다.

구분	주요 내용
1장. 일러두기	개발 배경, 주요 독자와 활용법, 정책 참조용 템플릿 및 전문적 진단·치료 대체 불가 원칙, 국내외 참고자료
2장. 핵심 요약	가이드북의 목적·필요성, 5대 핵심 원칙, 6대 권고사항, 대상별 활용 안내와 기대효과
3장. 의과대학생 정신건강관리의 중요성	국제 현황과 2025년 정신건강 실태조사의 임상척도, 학년·성별 비교, 절단점 초과 비율 및 시사점
4장. 의과대학 학생정신건강 권고안	학생상담센터 운영, 제도적 보장, 위기대응체계, 교육과정 내 정신건강 교육, 낙인 감소·도움 요청 문화, 동료지원 프로그램

표 25 정신건강 상담 가이드북 목차별 주요내용 4. 활용 계획 완성된 「정신건강 상담 가이드북」은 전국 의과대학의 학생지원 담당자, 지도교 수, 상담 관련 교직원 및 학생을 대상으로 배포하여 학생 정신건강 지원을 위한 실무 참고자료로 활용할 예정이다.

각 대학이 자체 학생지원체계에 맞게 활용할 공하며, 전국 의과대학생 정신건강 실태조사 결과와 가이드북의 주요 내용 및 활용 방안을 공유하기 위한 교수 대상 워크숍을 운영하여 현장에서의 활용도를 높이 고자 한다.

향후에는 대학별 적용 사례와 이용자 의견을 지속적으로 수집·반영하여 가이드북 의 내용을 보완하고, 이를 교수-학생 간 소통과 관계 회복, 동료지원 프로그램 및 위기 대응체계 개선 등 학생 정신건강 지원체계의 고도화로 연계해 나갈 계획이 다.

구분	주요 내용
5장. 교수를 위한 학생 면담 가이드라인	상담 전 준비, 개인적·정서적 상담, 학업문제 상담, 집단 휴학 후 복귀 학생 상담, 정신건강 상담과 전문기관 연계
6장. 학생을 위한 가이드라인	위험신호 점검, 번아웃·우울·불안·중독·자해·자살생각 이해, 자기돌봄, 도움 청하기·동료 돕기, 위기 연락처와 흐름도
7장. 기타	정신건강 이외의 장학·진로·학업·관계 상담, 국내외 운영사례, 자가점검·마음챙김·위기자원 Toolkit
부록	권고안의 해외 근거, 학칙·학생지원규정 예시, 정신건강복지법상 입원 유형, 상세 운영자료, 자가점검 척도, 위기 연락처 목록

04 종합 사업 결과

V. 사업성과 1. 주요 성과 가. 현장 대응용 상담안내서 개발 및 전국 배포 사업 초기에는 의과대학 교수와 학생지도 담당자가 학생 면담에서 즉시 활용할 수 있도록 「상담안내서(Short Guide)」를 개발했다.

상담안내서는 상담의 기본 태도, 상황별 상담 접근, 상담 전 준비사항 등으로 구성되어 팸플릿과 PDF 형태로 제작했다.

2025년 5월 전국 40개 의과대학에 학교별 약 200부의 인쇄본과 PDF파일을 제공해 사업 초기 단계의 현장 대응자료를 마련했다.

나. 전국 의과대학생 정신건강 실태조사 학생생활 실태와 표준화 정신건강 척도를 결합한 총 166문항의 온라인 조사도구를 개발했다.

조사도구는 기본정보, 심리·정서 상태, 대인관계 및 공동체 경험, 학업, 진로·의사 정체성, 학교지원 경험과 함께 우울, 불안, 불면, 스트레스, 주의력, 사회적 지지, 자살 관련 경험 및 비자살성 자해 등을 포괄하도록 구성했다.

또한 연구계획서, 연구대상자 설명문·동의서, 모집공고문 및 자료관리계획을 마련하고 충남대학교병원 기관생명윤리위원회의 승인을 받아 전국 단위 조사를 수행하기 위한 연구·윤리적 기반을 확보했다.

전국 40개 의과대학을 대상으로 2025년 9월 15일부터 11월 30일까지 온라인 조사를 실시했으며, 총 35개 대학에서 6,071명이 설문에 참여했다.

이 가운데 3,373명이 전체 설문을 완료했고, 응답 내용과 자료의 적절성을 검토해 최종 3,313명의 분석자료를 구축했다.

전체 모집단 20,088명을 기준으로 한 응답률은 16.49%였다.

이를 통해 의과대학생의 정신건강 상태와 학생생활 실태를 종합적으로 파악하고, 성별·학년별 특성과 위험요인 및 보호요인을 분석할 수 있는 전국 단위 기초 자료를 확보했다.

다.

학생 경험을 반영한 혼합연구 수행 설문 문항 개발 전 약 6-7개 대학의 의예과와 의학과 학생 중 총 16명을 대상으로 사전 인터뷰를 실시해 교육환경 변화, 학업과 복귀 부담, 관계와 소속감, 진로·의사 정체성, 학교지원 및 도움 요청 경험을 조사내용에 반영했다.

온라인 조사 이후에는 25개 의과대학에서 추천받은 학생을 대상으로 사전 선별 절차를 거쳐 학년·지역·성별 및 위험 가능성을 고려한 5개 사후 초점집단면접(FGI) 그룹을 구성했다.

총 23명의 학생을 인터뷰했으며, 인터뷰는 심리·정서, 학업 및 교육환경, 대인관계와 사회적 지지, 학생지원 경험 및 요구, 진로와 정체성 등 5개 핵심 영역을 중심으로 반구조화 방식으로 진행했다.

정량조사 결과와 학생의 구체 적인 경험을 연계해 해석할 수 있는 질적자료를 확보함으로써, 설문 결과의 맥락 과 학생지원 요구를 확인하는 혼합연구 체계를 운영했다.

라. 정신건강 상담 가이드북 개발 및 전국 배포 실태조사와 인터뷰·사후 초점집단면접(FGI)에서 확인된 학생지원 요구를 토대로 「정신건강 상담 가이드북」 원고를 개발했다.

가이드북은 대학 차원의 학생 정신건강 지원 권고안, 교수용 학생 면담 지침, 학생용 자기점검·자기돌봄·도움 요청 안내, 위기대응 절차와 국내외 사례 및 실무 자료를 포함한 7개 장과 부록으로 구성 했다.

2026년 6월 말 최종 원고를 마련했으며, 7월에 전공의 검토 의견 반영과 학생 사용자 의견 수렴, 오타자 및 표·도식 재검토, 편집·디자인 단계를 거쳐 최종으로 KAMC 이사회 및 학장단 승인 절차를 거친 후 8월에 발간 후 배포했다.

마. 성과 공유 및 협력 기반 마련 사업 수행 과정과 중간 연구결과를 공유하기 위해 2025 대한의사협회 학술대회 및 제42차 의학교육학술대회에서 연구성과를 발표했다.

이를 통해 연구진, 의과대 학 관계자 및 학생지원 담당자들과 의과대학생 정신건강 실태와 학생지원 방안에 대한 의견을 공유하고, 연구결과의 활용 방향과 상담 지원체계 구축 방안에 대해 논의하는 협력 기반을 마련했다.

또한 연구성과가 전국 의과대학의 학생지원 정책 과 상담 현장에 효과적으로 활용될 수 있도록 참고할 수 있는 기초자료를 마련했 으며, 이를 토대로 향후 연구 결과 공유와 교수 대상 활용 워크숍을 통해 상담 가이드북의 현장 적용성과 활용도를 지속적으로 높여 나갈 계획이다.

2. 주요 산출물 표 26 사업 주요 산출물 3. 사업 운영 성과 가. 다학제 협력체계 구축 정신건강의학과와 의학교육 분야 연구진이 조사도구 개발, 위험·보호요인 해석, 인터뷰와 사후 초점집단면접(FGI), 학생지원 방안 및 상담 가이드북 개발에 공동으 로 참여했다.

전국 의과대학의 학장단, 실무교수와 학생대표로 이어지는 조사 협조 체계를 운영해 전국 단위 자료수집과 성과 확산의 기반을 마련했다.

나. 학생 위기 상황 대응을 위한 근거기반 지원 프로토콜 확립 학생 위기 상황에 대한 체계적인 대응체계를 마련하기 위해 단계적 개발 프로세스를 구축했다.

먼저 전국 의과대학이 공통적으로 활용할 수 있는 학생 상담안내 서(Short Guide)를 우선 개발하고, 전국 의과대학의 의견수렴과 협의를 통해 학생 지원의 기본 방향에 대한 공감대를 형성했다.

이를 기반으로 전국 의과대학생 정신건강 실태조사를 실시해 학생들의 정신건강 수준과 지원 요구를 체계적으로 파악했으며, 조사 결과를 심층적으로 해석하기 위해 사후 초점집단면접(FGI)을 수행 했다.

구분	산출물	주요 활용대상
1	상담안내서(Short Guide)	의과대학 교수 및 학생지도 담당자
2	사전 인터뷰 질문지와 분석자료	설문 개발 연구진
3	의과대학생 정신건강 실태조사 도구와 데이터	협회, 참여 대학, 연구진
4	전국 의과대학생 정신건강 실태조사 결과보고서	학생지원 담당자, 의학교육 관계자
5	사후 사후 초점집단면접(FGI) 질문지와 질적 분석자료	상담가이드북 개발 및 후속 연구
6	정신건강 상담 가이드북(Guidebook)	대학, 교수, 학생, 상담·지원 인력
7	학술대회 발표자료	의학교육 공동체 및 관계기관

이후 실태조사와 FGI에서 도출된 근거를 반영해 교수용·학생용 정신건강 상담 가이드북(Full Guide)을 개발함으로써, 초기 대응-실태 파악-심층 분석-지원도구 개발로 이어지는 근거기반 학생 위기 상황 대응 프로토콜을 확립했다.

4. 기대효과 본 사업은 전국 의과대학생의 정신건강 실태와 지원 요구를 체계적으로 파악하고, 이를 바탕으로 학생 정신건강 지원을 위한 기초자료와 실무지침을 마련했다는 데 의의가 있다.

개발된 상담안내서와 정신건강 상담 가이드북은 교수와 학생, 학생지원 담당자가 현장에서 활용할 수 있는 실무자료로 활용되어 학생의 위험 신호를 조기에 발견하고 적절한 상담 및 전문기관 연계를 지원하는 데 기여할 것으로 기대된다.

또한 전국 단위 실태조사 결과와 정신건강 상담 가이드북은 대학별 학생지원체계 개선과 예방 중심의 정신건강 지원정책 수립을 위한 기초자료로 활용될 수 있으며, 학생의 정신건강과 학습환경을 함께 고려하는 통합적 학생지원 문화 조성의 기반이 될 것으로 기대된다.

05 해석의 한계와 결론

표 29 우선순위 결정 기준과 권고 순위 7. 연구의 의의와 향후 과제 가. 연구의 의의 첫째, 본 연구는 의정사태가 장기화되고 학생들의 학업중단과 복귀가 진행될 시점에 전국 35개 의과대학 학생의 정신건강 상태와 지원 요구를 파악한 전국 단위 자료를 제공했다는 데 의의가 있다.

의정사태의 인과적 영향을 추정할 수는 없지만, 조사 시점에 어떤 위험집단이 존재하고 어느 학년과 영역에서 지원 필요가 컸는지를 확인할 수 있었다. 특히 잠재프로파일 분석을 통해 평균값만으로는 확인하기 어려운 고위험군과 잠재위험군을 구분함으로써 학생마다 필요한 지원의 수준이 다를 수 있음을 제시했다.

둘째, 사전 인터뷰, 전국 온라인 조사, 사후 FGI를 연계하여 ‘조사 시점에 관찰된 학생의 상태’와 ‘학생들이 의정사태 및 복귀 과정과 관련해 보고한 경험’을 함께 제시했다는 점에 의의가 있다.

정량조사를 통해 정신건강 상태와 위험 수준을 파악하고, FGI를 통해 불확실성, 신뢰, 관계, 공동체 및 진로 고민의 구체적인 맥락을 확인했다. 또한 정량자료와 정성자료의 역할을 구분함으로써 학생들의 경험을 구체적으로 이해하면서도 의정사태의 영향을 인과적으로 과도하게 해석하지 않도록 했다. 셋째, 연구 결과를 상담안내서와 정신건강 상담 가이드북으로 구체화하여 연구 결과가 실제 학생지원에 활용될 수 있는 형태로 전환했다는 점에 의의가 있다.

이

순위	과제	우선 근거	착수 시점	대상
1	신뢰 기반 정기 소통	FGI 전 그룹 공통 요구	0~6개월	모든 학생
1	가이드북 배포·핵심인력 워크숍	연구근거의 현장 실행 전환	0~6개월	학장단·교수·학생지원인력
2	교수교육·멘토링·동료지원	보호요인 강화	6~18개월	전 학년, 취약집단 강화
2	학업량·시험·휴식시간 점검	교육과정에서 생기는 부담 완화	6~18개월	교육과정 전체
3	전문직 정체성·진로지원	중장기 학업·진로 회복	6~36개월	특히 고학년
3	전국 반복조사·품질개선	지속가능성과 근거 축적	18~36개월	KAMC·전체 대학

를 통해 연구 결과를 보고서에 제시하는 데 그치지 않고 교수와 학생지원 담당자 가 학생 면담과 지원기관 연계에 활용할 수 있는 실무적 도구로 제시했다.

또한 결과와 정책 제언을 연결한 내용과 정책 로드맵은 각 대학이 현재 학생지원체계의 부족한 부분을 확인하고 우선적으로 추진할 과제를 설정하는 데 활용할 수 있다.

넷째, 가이드북 배포와 사례 기반 워크숍을 연계함으로써 연구 결과가 실제 현장 의 학생지원으로 이어질 수 있는 기반을 마련했다는 점에 의의가 있다.

가이드북 은 대학과 교수자가 공유해야 할 기본 원칙을 제시하고, 사례 기반 워크숍은 교수 자가 학생의 위험신호를 인지하고 경정한 후 적절한 지원기관으로 연결하는 과정 을 실제 사례를 통해 연습할 수 있도록 구성했다.

학생지원 담당자는 대학 내·외부 의 지원경로를 점검하고 이를 실제 운영체계에 반영할 수 있다.

이후 가이드북과 워크숍의 실제 활용 여부를 평가하고 그 결과를 다시 내용 개선에 반영함으로써 일회성 배포를 넘어 지속적인 개선으로 연결할 수 있다.

나. 연구의 한계 본 연구는 횡단적 자기보고 자료를 활용하였으므로 변수 간 인과관계를 확정할 수 없다.

특히 의정사태 이전에 동일 학생에게 동일한 척도를 적용한 자료가 없고, 의정사태를 경험하지 않은 비교집단도 확보하지 못했다.

따라서 조사에서 확인된 정신건강 부담 중 어느 정도가 의정사태, 학업중단 또는 복귀 과정과 관련되는지, 어느 정도가 일반적인 의학교육의 학업부담이나 본과 진입에 따른 부담에서 비롯 되는지를 구분할 수 없다.

학년별 차이 역시 의정사태 노출 정도, 입학 및 복귀 시 점, 기존의 학년효과 등이 함께 반영되었을 가능성이 있다.

또한 FGI에서 확인된 내용은 학생들이 의정사태와 관련하여 경험하고 인식한 부담을 보여주는 자료이지 만, 이를 근거로 의정사태가 정신건강 악화를 일으켰다 고 판단할 수는 없다.

모집단 대비 최종 분석대상자의 응답률은 16.49%였으며, 대학과 학년별 참여 규 모에도 차이가 있었다.

이에 따라 정신건강에 관심이 높거나 특정 경험을 가진 학 생이 상대적으로 많이 참여했을 가능성을 배제할 수 없다.

일부 척도의 컷오프는 임상적 진단기준이 아닌 선별기준이며, 잠재프로파일 분석에서 도출된 집단 역시 확정적인 진단집단을 의미하지 않는다.

자살·자해 관련 결과는 조사 시점과 응답한 경의 영향을 받을 수 있으므로 개인이나 대학을 낙인화하거나 평가하는 용도로 활 용해서는 안 된다.

또한 FGI는 목적표집된 23명의 경험을 심층적으로 보여주는 자 료이므로 그 빈도나 분포를 전체 학생에게 일반화할 수 없다.

다.

후속 연구 및 정책평가 과제 (1) 종단 추적 학년 전환과 복귀 전후의 정신건강, 학업지속 및 사회적 지지 변화를 추적하여 변수 간 시간적 선후관계를 확인할 필요가 있다.

(2) 대표성 개선 증화표집, 대학·학년별 모집전략, 비용답 분석 및 필요한 경우 가중치를 활용하여 전국 단위 추정의 타당도를 높일 필요가 있다.

(3) 도구 검증 학생 경험 지표와 위험프로파일의 신뢰도, 타당도 및 측정동일성을 검증하고, 임상적 선별과 지원 연계에 대한 적절성을 평가할 필요가 있다.

(4) 프로그램 효과평가 전환기 프로그램, 외부상담 연계, 교수교육, 동료지원 및 정기적 소통을 단계적으로 도입하고, 참여율과 만족도뿐 아니라 정신건강, 학업지속, 서비스 연결 완료 여부 및 집단별 이용 격차가 개선되는지를 평가할 필요가 있다.

(5) 구현연구 대학 규모, 지역 및 자원 수준에 따른 실행 장벽과 촉진요인을 비교하여 공통적으로 적용해야 할 핵심요소와 대학 여건에 따라 조정할 수 있는 현장 적응요소를 구분할 필요가 있다.

(6) 학생 공동설계 연구질문, 조사도구, 서비스 설계, 결과해석 및 확산의 전 과정에 학생을 참여시켜 지원체계의 수용성과 윤리성을 높일 필요가 있다.

라. 결론 본 연구는 의정사태의 장기화와 학생들의 학업중단 및 복귀가 진행된 시점에서 전국 의과대학생의 정신건강 상태와 학생생활 경험, 그리고 학생지원 요구를 종합적으로 파악하고자 수행되었다.

전국 35개 의과대학 재학생을 대상으로 한 온라인 실태조사와 사전 인터뷰, 사후 초점집단면접(FGI)을 연계하여 조사 시점의 정신건강 상태와 학생들이 경험한 학업, 관계, 정보 제공, 상담 및 진로와 관련된 어려움을 함께 확인하였다.

또한 연구 결과를 상담안내서와 정신건강 상담 가이드북으로 구체화하여 조사 결과가 실제 학생지원으로 이어질 수 있는 기반을 마련하였다.

본 연구에서 확인된 정신건강 위험을 의정사태의 결과로 직접 해석해서는 안 된다.

동일 학생을 대상으로 한 의정사태 이전 자료와 비교집단이 없고, 횡단적 자기 보고 자료에 기반하고 있기 때문에 의정사태와 정신건강 간의 인과관계를 확인할 수 없기 때문이다.

특히 학년별 차이에는 의정사태에 대한 노출 정도뿐 아니라 본 과 진입, 학업중단과 복귀, 기존의 학년효과 등이 함께 작용했을 가능성이 있다.

따라서 본 연구의 결과는 의정사태의 정신건강 영향을 추정하는 자료라기보다, 해당 시점에 의과대학생에게 어떤 정신건강 위험과 학생지원 요구가 존재했는지를 보여주는 자료로 해석하는 것이 타당하다.

그럼에도 본 연구에서는 학생들의 정신건강 위험 수준이 균일하지 않았으며, 상당한 규모의 고위험군과 중간·잠재위험군이 존재함을 확인하였다.

또한 의학과 1학년을 비롯한 일부 전환기에 부담이 집중되는 양상이 나타났으며, 사회적 지지와 신뢰 관계는 중요한 보호요인으로 확인되었다.

FGI에서는 학업중단과 복귀 과정에 서의 불확실성, 학업 및 생활 부담, 관계와 공동체의 변화, 학교의 정보 제공과 소 통, 상담 이용의 장벽, 진로와 전문직 정체성 에 대한 고민이 구체적으로 보고되었 다.

이는 학생 정신건강을 개별 학생의 취약성이나 상담 이용의 문제만으로 접근 하기 어렵다는 점을 보여준다.

따라서 학생지원의 관점은 '문제가 발생한 학생을 상담하는 방식'에서 '모든 학 생의 웰빙을 지원하면서 위험 수준에 따라 필요한 지원을 연결하는 방식'으로 전 환될 필요가 있다.

모든 학생에게 정신건강 정보와 자기점검 기회를 제공하는 예 방적 접근을 기본으로 하되, 위험 신호가 확인된 학생에게는 조기상담과 지원을 제공하고, 전문적 인 치료가 필요한 경우에는 적절한 외부 전문기관으로 연계하며, 자살·자해와 같은 위기 상황에는 즉각적인 안전 확보와 전문적 대응이 이루어지는 단계적 지원 체계가 필요하다.

동시에 학생 정신건강을 개인적 문제로만 다루어서는 충분하지 않다.

학생이 경 험하는 학업량과 평가, 학사일정, 정보 제공과 소통, 교수-학생 관계, 동료관계와

2차년도·후속 방향

전국 모니터링과 대학별 실행·평가를 확대하고, 상담 가이드북과 교수 워크숍의 활용을 점검합니다. 학생 참여를 통해 지원체계의 접근성과 실효성을 개선하는 방향을 제안합니다.